PROFESIONAL

EJE 2 · ENFERMERÍA UNIVERSITARIA, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Reducción de la neumonía asociada a ventilación mecánica mediante un paquete de medidas en UCI (2022–2026)

Balacco, G.; Cesar, C.; Martínez, G.

Enfermero de Control de Infecciones · Comité de Control de Infecciones · Instituto de Investigaciones Médicas «Dr. Alfredo Lanari», Facultad de Medicina, UBA

1 INTRODUCCIÓN

La neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV) es una de las infecciones asociadas a dispositivos más frecuentes en las unidades de cuidados intensivos (UCI), con elevada morbimortalidad y prolongación de la estancia hospitalaria (Klompas et al., 2022). Su prevención se apoya en paquetes de medidas (bundles) y en la vigilancia activa a cargo de enfermería especializada (OPS, 2017).

En nuestra UCI se observaban tasas elevadas de NAV y, en el trabajo de campo, se identificaron prácticas inadecuadas de aspiración de secreciones y de reprocesamiento del material. Se implementó un bundle junto con la corrección de esas prácticas, bajo una vigilancia reforzada con un enfermero de control de infecciones (ECI) exclusivo.

2 OBJETIVOS

Describir el impacto de la implementación de un paquete de prevención de NAV, junto con la corrección de prácticas de aspiración de secreciones y de reprocesamiento del laringoscopio, sobre la tasa de neumonía asociada a ARM en la UCI del instituto durante el período 2022–2026.

3 METODOLOGÍA

Diseño: estudio descriptivo, observacional y longitudinal.

Ámbito y período: UCI del Instituto «Dr. Alfredo Lanari» (UBA); enero 2022 a agosto 2026.

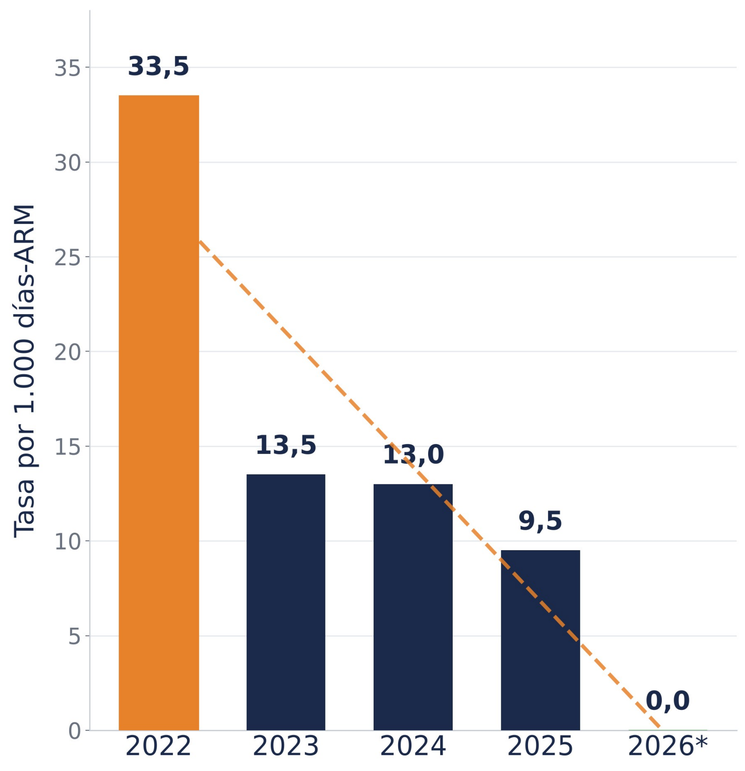
Población: pacientes internados en la UCI bajo asistencia respiratoria mecánica (ARM).

Vigilancia: registro diario de días de ARM y de episodios de NAV. Tasa = (episodios / días de ARM) × 1.000. Las definiciones de caso y el cálculo de tasas siguieron los criterios del Programa Nacional VIHDA y de los CDC/NHSN.

Bundle de prevención: cabecera a 30–45°; higiene bucal con clorhexidina; evaluación diaria de sedación y extubación; manejo de secreciones; control de presión del balón; higiene de manos.

Medidas locales: corrección de la aspiración central (presión adecuada permanente) y reemplazo de frascos reservorio por descartables confiables; reprocesamiento de ramas de laringoscopio (detergente pentaenzimático + desinfección de alto nivel); más dispensers de alcohol en gel; higiene ambiental con servicios generales. Datos agregados, sin información que identifique pacientes.

4 RESULTADOS



* 2026: enero–agosto (parcial)

Figura 1. Tasa de NAV por 1.000 días-ARM, 2022–2026 (2026: ene–ago). Fuente: elaboración propia.

0
Casos de NAV en 2026 (enero–agosto)

≈72%
Reducción de la tasa de NAV (2022 vs. 2025)

La tasa de NAV mostró una marcada reducción sostenida: 33,5 por 1.000 días-ARM en 2022; 13,5 en 2023; 13,0 en 2024; y 9,5 en 2025, sin episodios en lo que va de 2026 (enero–agosto).

La reducción entre el año inicial y el último año completo (2022 vs. 2025) fue de ≈72%. En todo el período se registraron 30 episodios sobre 1.657 días de ARM. La corrección de la aspiración y del reprocesamiento del laringoscopio coincidió con la fase de mayor descenso.

La adherencia a la higiene de manos se mantuvo entre 50% y 60%, sin mejora sostenida, lo que resalta el peso de las intervenciones de proceso y de la vigilancia activa.

5 CONCLUSIONES

MENSAJE CLAVE

Un bundle de prevención sumado a la corrección de prácticas locales de aspiración y reprocesamiento se asoció a la caída de la NAV, hasta la ausencia de casos en el último período.

La combinación de un bundle basado en evidencia con la identificación y corrección de prácticas inadecuadas propias de la unidad se asoció a una reducción sostenida de la NAV, hasta la ausencia de casos en 2026.

Como limitaciones, es un estudio observacional con escaso número de episodios por período, por lo que los resultados se interpretan como tendencia. La adherencia a la higiene de manos permanece como oportunidad de mejora.

6 APORTE A ENFERMERÍA

El trabajo evidencia el valor de la observación de enfermería en terreno para detectar fallas del proceso —muchas veces invisibles en los registros— y convertirlas en mejoras concretas y de bajo costo. La metodología y las intervenciones son replicables en otras UCI y jerarquizan el rol de la enfermería de control de infecciones en la seguridad del paciente.

7 REFERENCIAS

Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA). (2024). Reporte Anual Programa VIHDA 2024. INE–ANLIS, Ministerio de Salud de la Nación (Argentina).

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2003). Guidelines for preventing health-care-associated pneumonia. MMWR, 53(RR-3). CDC / NHSN.

Klompas, M., Branson, R., Cawcutt, K., et al. (2022). Strategies to prevent ventilator-associated pneumonia and non-ventilator hospital-acquired pneumonia: 2022 update. Infection Control & Hospital Epidemiology, 43(6), 687–713.

Contacto: Comité de Control de Infecciones · infectologia@lanari.uba.ar

QR (opcional)